



Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé

N° de déclaration d'activité 93.83.04918.83 *Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat*

FINESS EJ : 83 000 904 9 - SIRET : 130 016 561 000 40 - Code APE 8412Z - DATADOCK : 0014425 DPC : 1073

Siège administratif : 95 rue Montebello – 83000 TOULON

BEYER SEBASTIEN

Analyse de pratiques professionnelles

Stage n°3 : S.U.C. Chirurgie viscéral/vasculaire & ori

Semestre 2

Manipulateur en électroradiologie médicale, 25/28

Étudiant en première année de formation de manipulateur en électroradiologie médicale, j'ai effectué un stage du 16/03/2026 au 12/04/2026 au sein d'un service de chirurgie viscérale, vasculaire et ORL, dans un établissement public de la région PACA.

Ce service est organisé autour d'un long couloir comprenant quinze chambres. L'équipe est composée, hors étudiants, d'une infirmière (occasionnellement doublée le matin), d'une aide-soignante et d'une ASH. Les prises en charge y sont variées, allant de pathologies bénignes à des situations plus lourdes.

La situation décrite s'est déroulée lors de la troisième semaine de mon stage.

Description de la situation

J'ai été confronté à la prise en charge de Mme X, une patiente enceinte de triplés, à environ quatre mois et demi de grossesse, grossesse classée à risque, hospitalisée pour *Hyperémèse gravidarum* et vertiges importants : c'est une forme extrême de nausées et de vomissements pouvant mener à une déshydratation et une perte de poids dangereuse, associée à des vertiges sévères même en position assise. Ces symptômes avaient entraîné une diminution significative des apports alimentaires, avec une glycémie capillaire mesurée depuis quelques jours à 3,8 mmol/L, traduisant une situation limite sachant qu'une glycémie à jeun dite normale pour une femme non enceinte est déjà de 3,9 à 5,5 mmol/L. La patiente présentait une altération de l'état général et restait alitée en permanence. Elle adoptait spontanément une position en décubitus latéral gauche, qu'elle décrivait comme plus confortable, mais qui lui occasionnait des douleurs articulaires du fait du maintien prolongé de cette position.

La situation était rendue complexe par un contexte de coordination difficile du parcours de soins, avec des orientations successives entre différentes spécialités n'ayant conduit à aucune stratégie thérapeutique.

Par ailleurs, un épisode antérieur aux urgences, au cours duquel un traitement potentiellement contre-indiqué pendant la grossesse avait failli être administré, avait majoré la méfiance de la patiente envers le système de soins. Face à une patiente dont la confiance avait été altérée par des expériences antérieures, j'ai compris que toute intervention, même non médicamenteuse, nécessitait une reconstruction préalable du lien thérapeutique. Cette alliance ne pouvait se construire que dans la durée et la constance — deux ressources que ma position d'étudiant disponible rendait accessibles, là où les contraintes organisationnelles du service limitaient objectivement le temps de présence des professionnels auprès de cette patiente. Ce mécanisme de méfiance illustre des processus psychologiques tels que le

conditionnement négatif et la perte de confiance envers le système de soins, notions abordées en UE 1.1 Psychologie.

Contexte clinique préalable à mon intervention

La veille de ma prise en charge, le médecin avait posé le diagnostic de vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) — après une première tentative diagnostique non concluante le jour précédent, la patiente étant dans l'impossibilité d'ouvrir les yeux, signe en lui-même révélateur de l'intensité des symptômes. Le diagnostic repose sur l'observation du *nystagmus* : mouvement oculaire involontaire et rythmique, signe clinique objectif permettant de confirmer l'origine vestibulaire des vertiges et d'orienter le diagnostic (HAS). Une fois le nystagmus visualisé lors d'une seconde tentative le jour suivant, le médecin avait réalisé une manœuvre de repositionnement des otolithes — vraisemblablement la manœuvre d'Epley, référence pour le VPPB du canal postérieur — consistant en une séquence de positions successives de la tête et du corps visant à déplacer par gravité les *otolithes* (cristaux de carbonate de calcium) hors du canal semi-circulaire vers l'utricule, où ils deviennent asymptomatiques (SFORL, 2023).

Cette manœuvre génère fréquemment une recrudescence transitoire des symptômes dans les heures suivantes, ce que la patiente avait effectivement présenté : vomissements importants et vertiges intenses au décubitus tout au long de la journée. Par ailleurs, même lorsqu'elle est mécaniquement efficace, la manœuvre nécessite un temps de recalibration centrale : le cerveau doit intégrer les nouvelles informations sensorielles et supprimer les réponses réflexes inadaptées mises en place pendant la phase symptomatique. Des vertiges et nausées résiduels peuvent ainsi persister sans nouvelle cause mécanique identifiée (SFORL, 2023). C'est précisément dans cette fenêtre thérapeutique — entre la correction mécanique réalisée et la récupération fonctionnelle non encore acquise — que mon intervention s'est inscrite.

Problématique

Comment, en tant qu'étudiant MERM en stage infirmier, adapter une prise en charge non médicamenteuse chez une patiente atteinte d'hyperémèse gravidarum sévère associée à un VPPB (vertige positionnel paroxystique bénin), afin de lever les obstacles sensoriels à la mobilisation et à la reprise alimentaire, tout en respectant mon champ de compétences et en garantissant la sécurité de la patiente ?

Analyse et démarche de prise en charge

Après analyse de la situation clinique, j'ai entrepris des recherches afin de construire une prise en charge adaptée, exclusivement non médicamenteuse, en veillant à ne pas empiéter sur le domaine médical et dans une démarche de sécurité indispensable.

Bien que la mobilisation au fauteuil et la marche aient été préconisées par l'équipe médicale, l'intensité des symptômes de la patiente rendait ces objectifs inapplicables en l'état. En tant qu'étudiant, j'ai identifié que mon rôle était de lever les verrous sensoriels (vertiges et nausées) pour permettre cette levée, indispensable pour prévenir les risques liés à l'alitement prolongé, tels que les complications thromboemboliques (phlébites) ou la fonte musculaire.

Ma démarche visait donc à concourir à l'objectif de mobilisation fixé par les médecins, en créant un environnement sécurisé et une stabilité symptomatique préalable. Cette étape de transition était le maillon manquant pour transformer une prescription théorique en une réalisation pratique et sécuritaire.

Dans cette réflexion, j'ai rapidement identifié que la priorité n'était pas directement la réalimentation, mais bien la diminution des symptômes.

L'analyse de la situation selon le modèle de Henderson, comme étudié dans l'U.E.3.11, met en évidence plusieurs besoins fondamentaux perturbés : le besoin de se mouvoir et maintenir une bonne posture, le besoin de manger et boire, et le besoin d'éviter les dangers. Ce cadre m'a permis d'identifier une hiérarchie d'intervention : la sécurité et la stabilisation symptomatique constituaient un préalable indispensable à la mobilisation, elle-même condition d'une reprise alimentaire durable.

Il m'apparaissait difficile d'envisager qu'une patiente puisse accepter de manger, de se mobiliser ou même de prendre certains traitements si elle était en permanence envahie par des sensations de vertige et de nausée. Cette approche rejoint les principes de la prise en charge vestibulaire, où la littérature indique notamment que la rééducation n'est envisageable que lorsque le patient n'a plus de nausées ou de vomissements (SFORL, 2023).

Après avoir échangé avec une infirmière du service du protocole personnalisé que je comptais mettre en place, et sans opposition par celle-ci, j'ai pu m'entretenir avec la patiente et après obtention de son accord démarrer la prise en charge spécifique.

Interventions — Jour 1

J'ai dans un premier temps adapté l'environnement, en réalisant certains soins en pénombre afin de limiter les stimulations visuelles susceptibles d'aggraver les symptômes. Cette démarche s'inscrit dans une logique de réduction des stimulations sensorielles, cohérente avec les recommandations de prise en charge des nausées de la grossesse.

Dans la continuité de cette réflexion, j'ai matérialisé un point fixe visuel à l'aide d'un morceau de sparadrap placé dans le champ de vision de la patiente, à hauteur des yeux. L'objectif était de stabiliser le regard et de limiter les mouvements oculaires, dans la logique des exercices de rééducation vestibulaire consistant à maintenir le regard sur une cible fixe (SFORL, 2023). Cette stratégie prend en compte le caractère multisensoriel des troubles vestibulaires, liés à une discordance entre les informations visuelles et vestibulaires.

J'ai également structuré la mobilisation de manière progressive, en relevant le lit par paliers d'environ quinze degrés toutes les deux minutes, dans une logique d'adaptation progressive du système vestibulaire. Une fois redressée, la patiente restait quelques minutes assises, les pieds ancrés au sol, en fixant le point visuel, avant d'être installée au fauteuil.

J'ai introduit l'utilisation du froid dans un objectif symptomatique : avant la mobilisation, j'ai appliqué une poche de froid sans contact direct au niveau de la nuque ; une fois la patiente installée au fauteuil, j'ai appliqué un linge très froid sur le visage pendant environ trente secondes. Cette stimulation visait à apporter une information sensorielle forte et prioritaire au cerveau, susceptible de diminuer les sensations de vertige et de nausée (Castellani & Young, 2016). J'ai volontairement limité la durée d'application pour éviter d'induire une thermogénèse compensatoire chez une patiente dont les réserves énergétiques étaient déjà très faibles (glycémie à 3,8 mmol/L).

L'amélioration observée lors de l'application des linges froids ne fait pas consensus et pourrait également s'expliquer par l'effet placebo. Comme le soulignent Meissner et al. (2020) et Benedetti (2014), le placebo déclenche une réponse biologique réelle capable de moduler les symptômes. Il convient de préciser que l'effet placebo dans ce contexte est éthiquement acceptable : aucune croyance fausse n'a été induite chez la patiente — une technique réelle a été appliquée, et c'est la réponse physiologique qui a pu dépasser le seul mécanisme direct. Dans cette situation critique, que le soulagement provienne d'un mécanisme physiologique direct ou d'un effet placebo importait peu face au confort retrouvé de la patiente.

Lors de cette première mise au fauteuil, la patiente a pu rester environ quinze minutes sans présenter ni vertige ni nausée. À ce stade, aucune tentative d'aide à l'alimentation de ma part n'avait encore été initiée, mon objectif était uniquement de stabiliser les symptômes. J'ai interprété cette durée comme une réussite. Le retour au lit a été demandé en raison d'une gêne liée à la position et à une sensation de compression abdominale.

Interventions — Jour 2 et ajustements

Le lendemain, après réévaluation et nouvelles recherches, j'ai ajusté ma prise en charge. J'ai mobilisé un matériel disponible au sein de l'établissement — un fauteuil inclinable permettant

un réglage dissocié du dossier et des membres inférieurs, sans à-coups. Contrairement au fauteuil standard du service, ce dispositif permettait d'incliner le dossier à environ 110-120 degrés sans majorer la compression abdominale.

J'ai complété cette installation par plusieurs adaptations : un drap plié sous la fesse droite afin de favoriser une inclinaison vers la gauche et limiter la compression de la veine cave inférieure par l'utérus gravide — phénomène relevant de l'anatomie du tronc (UE 2.2) et de la physiologie vasculaire en contexte de grossesse multiple (UE 2.5) —, un soutien lombaire à l'aide d'un linge roulé, un drap en boudin sous les cuisses pour éviter un glissement, et un drap en U sous le ventre afin de soulager le poids abdominal et le diaphragme.

Aide à la reprise alimentaire

Au bout d'une heure, l'absence de symptômes a permis d'envisager une tentative d'alimentation progressive. Après m'être assuré auprès de la diététicienne de l'absence de contre-indication alimentaire, j'ai préparé une collation composée d'un mélange de yaourt, de beurre et de sucre, maintenue au congélateur une dizaine de minutes pour obtenir une texture très froide.

La patiente bénéficiait déjà d'une alimentation prescrite libre à sa convenance, apportée régulièrement par l'équipe soignante. Cependant, les plats servis — chauds, odorants — constituaient en eux-mêmes des stimuli sensoriels déclencheurs de nausées, rendant toute prise alimentaire quasi impossible. Mon intervention ne visait donc pas à réintroduire l'alimentation au sens strict, mais à modifier les conditions sensorielles dans lesquelles elle était proposée, afin de la rendre tolérable.

Cette stratégie repose sur l'utilisation du froid pour limiter l'ensemble des stimuli sensoriels déclencheurs de nausées : la basse température bloque la diffusion des odeurs (stimuli olfactifs) et anesthésie légèrement les papilles (stimuli gustatifs), permettant de faire accepter plus facilement les aliments (Tan et al., 2020).

J'ai associé à cette pratique l'hyperfractionnement, conformément aux recommandations de la HAS et du CNGOF. Ce principe consiste à multiplier les prises alimentaires en très petites quantités afin d'éviter le vide gastrique, qui aggrave les nausées et l'hypoglycémie. En proposant des aliments froids à forte densité énergétique mais en petits volumes répétés, on parvient à soutenir l'état nutritionnel dans un contexte de grossesse multiple et de dénutrition.

La patiente, qui ne consommait habituellement pas de beurre en raison de ses nausées, a néanmoins pu en ingérer dans ce contexte sans rejet, ce qui l'a elle-même surprise. Je lui ai conseillé de consommer ce mélange par micro-cuillères, sans contrainte de temps, sans pression, sans discours moralisateur, en précisant que toute quantité ingérée était bénéfique.

Elle a rapporté une meilleure tolérance tant que l'aliment restait froid, celui-ci devenant écoeurant en se réchauffant, ce qui est cohérent avec les recommandations de la littérature (Tan et al., 2020).

Environ deux heures après la prise de la collation, une glycémie capillaire de contrôle indiquait 4,9 mmol/L, contre 3,8 mmol/L depuis plusieurs jours. Si cette valeur reste modeste et ne permet pas de conclusions définitives, elle constituait le premier signe objectif d'une reprise des apports énergétiques. Mais au-delà du chiffre, c'est la dimension psychologique de ce moment qui m'a semblé tout aussi significative : la patiente avait pu s'alimenter sans nausée, sans vomissement, sans appréhension — et sans contrainte. Elle-même en était surprise. Cette expérience positive rompait partiellement le cercle vicieux dans lequel elle était enfermée depuis plusieurs jours : la nausée entraînant le refus alimentaire, aggravant l'hypoglycémie, elle-même facteur aggravant des nausées. Permettre une première expérience alimentaire réussie, même modeste, constituait ainsi un levier à la fois physiologique et psychologique, en lien avec les notions d'alliance thérapeutique et de relation de soin abordées en UE 4.2.

Limites et réflexivité

J'ai veillé à rester strictement dans mon champ de compétences, en me limitant à des interventions non médicamenteuses, sans interférer avec ce qui relève du domaine médical. Cette posture s'inscrit dans le respect du cadre réglementaire définissant les droits et devoirs du professionnel de santé en formation, tel qu'étudié en UE 1.3 Législation, éthique et déontologie.

Cette situation m'a également amené à réfléchir à ma posture d'étudiant. N'étant pas responsable d'un secteur, j'ai pu consacrer davantage de temps à l'observation, à l'analyse et à l'adaptation de la prise en charge. À l'inverse, les professionnels doivent gérer simultanément plusieurs patients avec des contraintes organisationnelles importantes. Il ne s'agit en aucun cas d'une critique, mais d'un constat des réalités du terrain. Cette expérience m'a permis de comprendre que la disponibilité de l'étudiant peut constituer une ressource complémentaire, à condition de s'inscrire dans une démarche collaborative.

Elle m'a également conduit à mobiliser des compétences relationnelles et communicationnelles essentielles dans le lien thérapeutique — écoute active, reformulation, adaptation du discours à l'état émotionnel de la patiente — telles qu'abordées en UE 4.2 Relation de soin et communication avec la personne soignée.

Conclusion

Cette situation illustre la complexité du raisonnement clinique, où il n'existe pas de réponse unique. Si, dans ce contexte précis d'hyperémèse avec vertiges intenses, le traitement des symptômes a constitué un préalable nécessaire à la mobilisation, cela met en évidence l'importance d'une approche globale et individualisée. Toute la difficulté du soignant réside dans sa capacité à adapter sa stratégie en fonction du patient et de son état clinique, tout en acceptant une part d'incertitude dès lors que la sécurité est assurée et que le bénéfice est réel.

Cette expérience en unité de soins m'a permis d'acquérir des compétences directement transposables à l'exercice futur de mon métier de manipulateur en électroradiologie médicale. En effet, le MERM est quotidiennement confronté, en salle de radiologie ou au scanner, à des patients présentant des troubles de la vigilance, des nausées ou des vertiges lors des transferts. La maîtrise des techniques de mobilisation progressive par paliers et l'utilisation de points d'ancrage visuels constituent désormais pour moi des outils précieux pour sécuriser le passage d'un brancard à une table d'imagerie, limitant ainsi le risque de chute ou de malaise.

Par ailleurs, la capacité à moduler l'environnement, notamment par la mise en pénombre de la salle, apparaît comme un levier essentiel pour apaiser un patient en souffrance sensorielle lors d'un examen. Cette vigilance s'étend au positionnement anatomique et physiologique, comme la prévention de la compression de la veine cave chez la femme enceinte, savoir indispensable pour garantir la sécurité lors d'une IRM obstétricale. Enfin, face à des patients parfois méfiants suite à des parcours de soins complexes, les techniques de communication et d'écoute active sont la clé pour restaurer une alliance thérapeutique indispensable à la réalisation d'un acte d'imagerie de qualité.

Cette situation démontre que la mission du manipulateur englobe une expertise clinique globale, visant à garantir la sécurité et la dignité du patient tout au long de sa prise en charge.

Bibliographie

Société Française d'Oto-Rhino-Laryngologie et de chirurgie de la face et du cou (SFORL). Place de la rééducation dans la prise en charge des vertiges d'origine vestibulaire. Recommandation de pratique clinique, 2023.

Pages utilisées : 18, 42-43, 82. PDF :

<https://www.sforl.org/wp-content/uploads/2023/08/Reco-Place-de-la-reeducation-dans-la-prise-en-charge-des-vertiges-dorigine-vestibulaire-16-08-2023.pdf>

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF). Nausées et vomissements gravidiques et hyperémèse gravidique : consensus formalisé d'experts. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie, 2022. PDF disponible ici :

<https://cngof.fr/app/uploads/2025/11/Nausees-et-vomissements-gravidiques2022-CFE.pdf>

Assurance Maladie (ameli). Nausées et vomissements au cours de la grossesse : que faire ? Page consultée en ligne :

<https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/nausees-et-vomissements-pendant-la-grossesse/nausees-vomissements-que-faire>

Assurance Maladie (ameli). Nausées et vomissements chez la femme enceinte : consultation et traitement. Page consultée en ligne :

<https://www.ameli.fr/assure/sante/devenir-parent/grossesse/difficultes-et-maladies-pendant-la-grossesse/grossesse-nausees-et-vomissements/nauses-vomissements-grossesse-consultation-traitement>

Assurance Maladie (ameli). Grossesse : nausées et vomissements. Page d'ensemble :

<https://www.ameli.fr/assure/sante/devenir-parent/grossesse/difficultes-et-maladies-pendant-la-grossesse/grossesse-nausees-et-vomissements>

Haute Autorité de Santé (HAS). Vertiges positionnels paroxystiques bénins : manœuvres diagnostiques et thérapeutiques – recommandations. Page consultée en ligne :

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2821340/fr/vertiges-positionnels-paroxystiques-benins-manoevres-diagnostiques-et-therapeutiques-recommandations

Castellani JW, Young AJ. Human physiological responses to cold exposure. Comprehensive Physiology. 2016. Résumé/indexation PubMed :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26924539/>

Benedetti F. Placebo effects: from the neurobiological paradigm to translational implications. Neuron. 2014. Résumé PubMed :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25442940/>

Meissner K, et al. Molecular classification of the placebo effect in nausea. PLOS ONE. 2020. Texte intégral :

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238533>

Tan PC, et al. Taste, smell and food-related nausea and vomiting responses in hyperemesis gravidarum. BJOG / texte intégral PMC. 2020.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7064589/>

Bustos M, et al. Nausea and Vomiting of Pregnancy – What’s New? Autonomic Neuroscience / revue en accès PMC. 2016. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5107351/>

Darley JM, Latané B. Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology. 1968 ; 8(4) : 377-383. DOI : 10.1037/h0025589.

Résumé PubMed : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5645600/>

Henderson V. Principes fondamentaux des soins infirmiers. Genève : Conseil International des Infirmières ; 1969. Référence catalogue :

https://www.centredoc.chu-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=471